Oddelek za psihiatrijo
Oddelek za psihiatrijo

MARIBOR, 03.04.2026

ODPUSTNO PISMO

DRAUČBAHER PETER
OŽBALT 53

2361 OŽBALT

Rojen-a	17.09.1984	KZZ: 040003336
Reg.št.	5025074112	
Podjetje	ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALI	
Dodat.zav.		
Zap.štev.	681226 33	
Matična št.	976097	
Velj.nap.	**TRAJNA NAP.**	

Datum, ura sprejema	*Dat.,ura adm.odp.*	*Št. hospital. dni*
12.01.2026 18:40	03.04.2026 10:48	81

Datum odpusta: 03.04.2026 *Merilo ustreznosti sprejema:* 18

Sprejemni zdravnik: MAJA RANILOVIĆ, dr. med., specialistka psihiatrije
Sobni zdravnik: doc.dr. ANJA PLEMENITAŠ ILJEŠ, dr. med., spec. psihiatrije
V. d. predstojnika Oddelka za psihiatrijo: JURE KOPRIVŠEK, dr. med., spec.psihiatrije

DIAGNOZA

02.04.2026 - F200 Paranoidna shizofrenija
02.04.2026 - F601 Shizoidna osebnostna motnja
03.04.2026 - I10 Arterijska hipertenzija

IZVIDI MEDODDELČNIH OBRAVNAV

FE: 421 Laboratorij nuklearne medicine
Datum, ura obravnave: **13.01.2026 08:58**
Zdravnik: prim. MITJA TOPALOVIČ, dr. med., spec. internist

LABORATORIJSKI REZULTATI

12.01.2026 19:05 TSH=1.71; FT4=16.96; FT3=5.27;

12.01.2026 19:44 K-Hemogram: K-levkociti=10.28; K-eritrociti=6.33; K-hemoglobin=154; K-hematokrit=0.47; MCV=73.8; MCH=24.3; MCHC=330; K-trombociti=282; Diferencialna krvna slika: K-nevtrofilni granulociti=6.13; K-limfociti=3.23; K-monociti=0.67; K-eozinofilni granulociti=0.20; K-bazofilni granulociti=0.05; K-nezreli granulociti=0.03; K-nevtrofilni granulociti=59.7; K-limfociti=31.4; K-monociti=6.5; K-eozinofilni granulociti=1.9; K-bazofilni granulociti=0.5; K-nezreli granulociti=0.3; P-amoniak=22; U-specifična teža=1.016; U-pH=7.5; U-nitriti=negativno; U-proteini=0; U-glukoza=0; U-metilketoni=0; U-urobilinogen=<17; U-bilirubin=0; U-eritrociti=11; U-levkociti=5; U-bakterije=13; U-cilindri=0; U-epitelne celice=0; U-eritrociti=0 - 3; U-levkociti=0 - 5; U-bakterije=Malo; U-cilindri=0; U-epitelne celice=0; K-RDW-CV=14.3; K-MPV=10.2;

12.01.2026 19:44 S-folati=27.1; S-vitamin B12=492; S-vitamin D=34.8;

ZAKLJUČEK

41-letni pacient je bil ponovno hospitaliziran na našem oddelku zaradi poslabšanje osnovne bolezni po opustitvi medikamentozne terapije. V tukajšnjo UPA je prišel samoiniciativno, brez napotnice. Gre za pacienta, ki je bil večkrat hospitaliziran v tukajšnji ustanovi, nazadnje v letu 2023, po tem se je vodil pri

dr. Klemen v ZD Adolfa Drolca Maribor.

Ob sprejemu je bil luciden, orientiran, zunanje še dokaj urejen, očesni stik je mestoma vzpostavljal. Bil je formalno urejenega duktusa, v vsebinskem delu je iznašal blodnjave vsebine, do katerih je bil deloma kritičen. Motnje zaznave je zanikal in se ni prikazal pod vplivom le teh. Razpoloženjska lega je bila v skladu z aktualnim psihičnim stanjem. Afektivno je bil odmaknjen, ni bil avto- ali heteroagresiven, prav tako ne akutno suicidalno ogrožen. Presoja realnosti je bila še vzpostavljena. Bil je trezen (AT 0,00 mg/L v izdihanem zraku).

Sprejet je bil na varovano enoto D2, s sprejemom je soglašal in podpisal ustrezne obrazce. Po sprejemu je bil blago razrahljanega duktusa, iznašal je blodnjav sistem, opisoval je fenomene vplivanja misli. Razpoloženjska lega je bila znižana, v ospredju je bila negativna simptomatika (hipobulija, psihomotorna upočasnjenost, slaba razgibanost afekta) osnovne bolezni. Samomorilno ni bil ogrožen, ni se prikazal kot avto- ali heteroagresiven.
Zaradi akutne psihotične simptomatike je bil v terapijo uveden antipsihotik paliperidon, katerega je bolnik prejemal že v preteklosti v obliki depoja, odmerke smo postopoma višali. Ob tem je z namenom anksiolize prejemal tudi lorazepam. Po potrebi je imel ob nespečnosti predpisan zolpidem. Zaradi znižanih vrednosti vitamina D, je dobival kapljice vitamina D3 enkrat tedensko.
Po ponovni uvedbi psihofarmakoterapije je bolnik pridobil ustrezni uvid v blodnjavo simptomatiko, le-te več spontano ni iznašal. Na skupinah delovne terapije na varovani enoti je zadovoljivo sodeloval.

Po zadovoljivi stabilizaciji psihičnega stanja je bil bolnik premeščen na Enoto za nadaljevalno zdravljenje B1 (odprta enota). V terapiji smo postopoma višali odmerke paliperidona do terapevtskega odmerka, nižali pa smo odmerke lorazepama do ukinitve. Ostala terapija je ostala nespremenjena. Gospoda smo motivirali, da bi se odločil za uvedbo paliperidona v obliki mesečne injekcije (depo), ki ga je v preteklosti že prejemal, vendar je to vztrajno zavračal. Na odprti enoti se je bolnik udeleževal vseh aktivnosti, sodeloval je po svojih zmožnostih, odobrene je imel tudi nekajurne izhode, iz katerih se je vračal v urejenem psihičnem stanju. Zavračal je stike z mamo in bratom.
V obravnavo se je vključila tudi naša socialna služba, ki je gospodu pomagala pri reševanju bivanjske problematike. Gospod je dobil bivanje okviru Zavoda Franko, s čemer je bil zadovoljen.

V osnovi je pri pacientu šlo za poslabšanje shizofrenije po opustitvi medikamentozne terapije. Po ponovni uvedbi antipsihotične terapije je produktivna psihopatološka simptomatika izzvenela, gospod blodnjavih vsebin spontano več ni iznašal, v mišljenju je ostal svojski.

Poleg psihičnega smo preverjali tudi somatsko stanje. Laboratorijske preiskave ob sprejemu so pokazale blago povišane vrednosti eritrocitov in levkocitov ter prav tako blago povišane vrednosti serumskega ALT (0.81) in AST (0.59). Preostale vrednosti krvnih preiskav so bile v mejah normale. Laboratorijska preiskava na alkohol v krvi je bila negativna, prav tako presejanje urina na prisotnost PAS. V hormonskih preiskavah je izstopala znižana vrednost vitamina D3, katerega smo nadomeščali; vrednosti folne kisline, vitamina B12 in ščitničnih hormonov so bile v mejah normale.
Ob povišanih vrednostih krvnega pritiska smo prilagajali terapijo z antihipertenzivom.

Z današnjim dnem ga v izboljšanem psihičnem stanju odpuščamo. Ob odpustu je luciden, vsestransko orientiran, umirjen in pogovorljiv. PPS zanika in ne deluje pod vplivom le-te. Razpoloženjska lega je brez bistvenih odklonov, ni suicidalen, ni avto- ali heteroagresiven.

ODPUŠČEN

Splošna navodila ob odpustu
Terapija ob odpustu:
- Invega tbl 12 mg zvečer, eRp sc I
- Prenessa tbl 8 mg zjutraj, eRp sc I

Svetujemo redno ambulantno psihiatrično vodenje, gospod je naročen na kontroli pregled po

hospitalizaciji k dr. Klemen v ZD Adolfa Drolca Maribor dne 9. 4. 2026 ob 10. uri.

api/DV

Odpustni zdravnik (lečeči/sobni/dežurni)
doc.dr. ANJA PLEMENITAŠ ILJEŠ, dr. med., spec. psihiatrije

Pacient mora odpustno pismo, ambulantni karton ali drugo medicinsko dokumentacijo izročiti svojemu osebnemu zdravniku ob prvem naslednjem obisku.

V primeru morebitnih naknadnih izvidov sledi Dodatek k odpustnemu pismu.

Pridržujemo si pravico, da v primeru morebitnega neustreznega kodiranja, spremenimo šifro diagnoze in/ali posega.

Spoštovani, vabimo vas, da podate vaše mnenje o zadovoljstvu z opravljeno zdravstveno obravnavo v UKC Maribor tako, da izpolnite vprašalnik. Pripravilo ga je Ministrstvo za zdravje v več jezikih, je anonimen in vam je neprekinjeno dostopen tako, da v svoj spletni brskalnik vpišete: zvem vprašalnik za paciente
Hvala za vaše sodelovanje !